

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696436 / 778

MARCIA BADIM DOS ANJOS

IDADE: 54 PESO: 73 ALTURA: 156 PROFISSÃO: Dentista
SINTOMAS: Cansaço diurno, refluxo (glaucoma)
QUEIXAS: Dorco
MEDICAMENTOS: ~~Do~~ Anastrozol (Bloqueio hormonal), colírio glaucomatol
Ocupress / glifage / vasucor / amitriptilina
MÉDICO: Dra Catharina
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N
EXERCÍCIO FÍSICO: não
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19:30
HORA QUE DORME: 00h HORA QUE ACORDA: 5:30 / 7:00
COCHILO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: não BANHEIRO: 1-2x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: - MALLAMPATI: IV IAH: 30,1 elh SPO2: 77,1 min
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Glaucoma / Dinite
CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

Masc. mureq Ex

11/06/24 Locação

18/06/24 P=4-8 cmH₂O / fixo P=5,6 cmH₂O (mediana)
IAH=0,3 elh
m. de uso: 6h44m Bem adaptada
fuga: 6,8 (percentil) diminuiu com o uso
Natacha

03/07 P=5,6 cmH₂O
24 IAH=0,6 elh
m. de uso: 5h58, Bem adaptada
fuga: 4 elh Natacha

12/07 P=5,6 cmH₂O
24 m. de uso: 5h15
IAH=0,3 elh
fuga de ar: 0,2 lpm. Sue

14/08 P=5,6 cmH₂O
24 IAH=0,4 elh
m. de uso: 6h32' Sue
fuga: 3,3 lpm.

03/09/24 $P = 5,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m de uso: 6 h 54'
fuga: 0,3 l/m

Bem adaptado
S/ queixas

Natacha

11/10/24 $P = 5,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m de uso: 5 h 54'
fuga: 0,0 l/m

Dilata este bem adaptada
não tendo mais dor de cabeça
Natacha

07/02/24 $P = 5,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m de uso: 6 h 6'
fuga: 1,1 l/m

Bem adaptada
 $\downarrow P = 5,2 \text{ cm H}_2\text{O}$ pois
ptu relata estar sentindo
incômodo

Natacha

12/05
25 $P = 5,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 6 h 50'
fuga = 2,9 lpu.

Ana Cláudio

07/07
25 $P = 5,2 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m de uso: 7 h 6'
fuga: 5,2 l/m

Bem adaptada
Oriento verificar filtro

Natacha

Dra. Catharina Soares de Andrade

Otorrinolaringologia - CRM 74.458 - RQE 17.180

Maria Badin de Nys

Encontro a Pádua

Perie p/ a deptus de
cl mp. (Palomus a axel)

DRA. CATHARINA SOARES DE ANDRADE
Otorrinolaringologista
CRM: 74458

Rua Paulo Setubal, 147 - 1º Andar - Sala 12
Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Tels. (12) 3922-4925 / 98260-1488

clínico
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Márcia Badim dos Anjos

EXAME nº: 5416

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 26/06/2023

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h12min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 10 minutos e a latência para o estágio REM, de 119 minutos. O tempo total de sono foi de 368,5 minutos (06h08min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 89,9%. A distribuição do sono mostrou 11,7% de estágio 1, 53,5% de estágio 2, 12,6% de estágio 3 e 22,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 31,5 minutos em vigília, ocorreram 82 microdespertares (índice: 13,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,1/hora, sendo 7,3 apneia/hora e 22,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 41/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 92% e a mínima de 77%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderado do índice de apneia/hipopneia (30,1/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e acentuado do índice de distúrbio respiratório (41/hora; índice acentuado: acima de 30/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM no decúbito dorsal, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 71; máxima: 91 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 10 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (119 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (89,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13,4/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,7%; normal: 8-10%) e REM (22,3%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (53,5%; normal: 45-55%) e 3 (12,6%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 14 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MACHADO
CRM-SP 62.858

NOME: Márcia Badim dos Anjos

EXAME nº: 5416-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 25/09/2023

IDADE: 54 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h13min e concluído às 06h18min. A latência para o sono foi de 34 minutos e a latência para o estágio REM, de 76 minutos. O tempo total de sono foi de 384,5 minutos (06h24min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,4%. A distribuição do sono mostrou 3,9% de estágio 1, 57,3% de estágio 2, 9,8% de estágio 3 e 29% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 7 minutos em vigília, ocorreram 43 microdespertares (índice: 6,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 5,6/hora, sendo 0,6 apneia/hora e 5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 5,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 92% e a mínima de 77%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7,8 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (5,6/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (5,6/hora), e alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 68; máxima: 86 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 34 min; normal até 30 min) – ela ingeriu um comprimido de zolpidem às 23h30min. A latência para o sono REM estava normal (76 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (90,4%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (6,7/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (57,3%; normal: 45-55%) e REM (29%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (3,9%; normal: 8-10%). A porcentagem do estágio 3 (9,8%; normal: 10-12%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Av. Dr. João Guilhermino, 474 salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12210-130 - fones: (12) 3941-2449 | 3913-2162

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730